

## מימנויות קיבוע

### אחיזת ראש לקיבוע

בנפגע טראומה או נפגע החשוד כנפגע עמוד שדרה או עמוד שדרה צווארי מבצעים אחיזת ראש ידנית לנפגע למניעת תזוזתו כדי למנוע תזוזת הראש וגרימת נזק לחוט שדרה צווארי. זאת הפעולה הראשונה שיש לבצע לאחר וידוא בטיחות הצוות. חשיבות אחיזת הראש היא מניעת תזוזת ראשו של הנפגע הן לצדדים הן אחורה וקדימה, ובכך שומרים על עמוד השדרה הצווארי ומונעים פגיעה נוספת אם יש חבלה.

- איש הצוות המבצע את אחיזת הראש יתמקם מאחורי ראשו של הנפגע, בין אם הוא שוכב ובין אם הוא יושב, למשל בתוך רכב.
- יש לאחוז בשתי ידיים את ראשו של הנפגע באזור האוזניים, אך אין לחסום את האוזניים כדי שהנפגע יוכל לשמוע את המתרחש סביבו.
- יש לאחוז את ראש הנפגע בעדינות אך ביציבות תוך כדי מתיחה קלה של הראש. מתיחה זו דרושה כדי למתוח מעט ובעדינות את חוליות הצוואר של הנפגע.



תמונה 25.46 צווארון פילדלפיה

### צווארון פילדלפיה

יש 2 גדלים של צווארון: צווארון מבוגרים מתכוונן וצווארון ילדים. לצווארון הילדים שני חלקים: חלק קדמי עם פתח קדימה ורווח מותאם לסנטר, וכן חלק אחורי המצויד ברצועות סקוץ' לשם הצמדתו לחלק הקדמי. לכל חלק יש צד עליון וצד תחתון. הצד העליון צר והצד התחתון רחב (רשום על הצווארון).

הצווארון מונע את תנועת ההנהון ("כן") של הראש - תנועת הראש למעלה ומטה, אולם הוא אינו מונע את תנועת הראש לצדדים ("לא").

### הנחת צווארון פילדלפיה בנפגע שוכב

- בעת קיבוע ראשו של הנפגע שומרים כל הזמן על קיבוע הראש ומניעת תזוזתו.
- מניחים תחילה את החלק האחורי של הצווארון ואחר כך את חלקו הקדמי.
- החלק האחורי של הצווארון גמיש מאוד, ולכן אפשר ליישר אותו ולמתוח את רצועות הסקוץ'.
- המטפל הראשון מחזיק את ראש הנפגע ומונע ממנו לזוז.
- המטפל השני מיישר את החלק האחורי של הצווארון, מכניס אותו בזירות מצד אחד של הצוואר ומתחתיו עד שהצווארון נמצא סימטרית משני צידי צווארו של הנפגע.
- המטפל השני מניח את חלקו הקדמי של הצווארון ומהדק את רצועות הסקוץ' אל החלק הקדמי.
- במשך כל הזמן הזה ראשו של הנפגע צריך להיות מקובע.

## העמסת נפגע ללוח גב

### לפני העמסת הנפגע על לוח הגב מבצעים כמה פעולות

- משולשי חבישה ישמשו רצועות קיבוע של הרגליים - קיבוע (שמינית) אחד באזור הקרסוליים ושני באזור הברכיים. קשירת המשולשים תיעשה בצד הרגל.
- מכינים 3 רצועות קיבוע ללוח הגב.
- מכינים מנייה ראש (head device) שני חלקים: חלק אחד יונח על לוח הגב ויוצמד על ידי כמה צמדנים (סקוצ'ים) וחלק שני - שתי כריות תומכות משני צידי ראשו של הנפגע שיוצמדו ברצועות (למצח ולסנטר).

**יש להפעיל שיקול דעת ולהחליט אם באמת יש צורך בכל רצועות הקיבוע והשמינית: נפגע שיש להורידו במדרגות בניין או נמצא עמוק בואדי יזדקק לכל הקיבועים. יש לשקול לפי הקינמטיקה**

**לאחר קיבוע ראשו של הנפגע בצווארון פילדלפיה וקיבוע רגליו במשולשי חבישה, אפשר להעמיסו ללוח הגב.**

- להעמסת נפגע ללוח גב נדרשים שלושה מטפלים:
  - המטפל הראשון ממשיך לקבע את ראש הנפגע ושני המטפלים האחרים מתמקמים משני צדדיו.
  - המטפל השני מרים את הנפגע לכיוונו במינימום טלטול, תוך כדי אחיזה בזרוע ובאגן.
  - אם יש יותר משלושה מטפלים, מטפל נוסף יכול לעזור להפוך את הנפגע על צידו כאשר הוא אוחז בו באגן ובירך ותוך כדי כך בודק חבלות ודימומים בחלק הגוף האחורי.
  - המטפל הראשון ממשיך לקבע את ראשו.
  - המטפל השלישי מכניס את לוח הגב מתחת לגבו של הנפגע.
- משכיבים את הנפגע על לוח הגב
- את שלוש הרצועות יש להשחיל בחריצים שבצידי הלוח. לשם כך מרימים בעדינות את הלוח בחלק התחתון) - באזור הרגליים, האגן והחזה
- אם הנפגע מחוסר הכרה - יש להצמיד את ידיו לגופו מתחת לרצועות החזה
- אם הנפגע בהכרה - יש להשאיר את ידיו משוחררות
- את מנייה הראש (head device) מניחים משני צידי הראש ומקבעים ברצועות - האחת באזור הסנטר והשנייה על המצח
- לעיתים יש צורך לקבע את ידיו של הנפגע זו לזו כדי שלא ייפגעו בעת העברתו לאמבולנס.

## הסרת קסדה

הסרת קסדה שייכת לשלב A.

אם הנפגעים חובשים קסדה, יש להסיר אותה מפניהם בשלב ההערכה הראשוני כדי לאפשר אבטחת דרכי אוויר פתוחות וכדי להעריך את מצב הנשימה. הסרת הקסדה מבטיחה שדימומים בחלק הראש האחורי לא יתנקזו אל תוך הקסדה. הסרת קסדה מאפשרת את קיבוע הראש בתנוחה ניטרלית. הסרת הקסדה מאפשרת גם להעריך את תנועת הראש והצוואר או לבדוק אם יש פגיעה בעמוד השדרה הצווארי במהלך ההערכה השניונית.

- להסרת קסדה נדרשים שני מטפלים:
  - מטפל אחד כורע מאחורי ראש הנפגע, אוחז בידיו בשני צידי הקסדה כשהאצבעות מתחת לחלקה התחתון
  - מקבעים את הראש והקסדה בתנוחה ניטרלית ככל האפשר
  - מטפל שני כורע לצידי הנפגע, מרים את מגן הפנים ופותח או גוזר את רצועת הקסדה
  - מטפל שני מחזיק ביד אחת את זווית הלסת של הנפגע וביד שנייה תומך בצוואר מאחור
  - את המרפקים משעינים על האדמה או על ירכי המטפל ליציבות
  - מטפל אחד מסיר את הקסדה בתנועות עדינות ואיטיות למעלה ולמטה
- יש לשים לב שלא למחוץ את אפו של הנפגע
- משהוסרה הקסדה מניחים ריפוד מתחת לראשו של הנפגע כדי לשמור על תנוחה ניטרלית ומניחים צווארון צווארון יונח לכל נפגע עם חשד לפגיעה בעמוד השדרה.